

Demencias – Alzheimer, Demencia Vascular y Demencia con Cuerpos de Lewy

1. Introducción y relevancia clínica

La **demencia** es un **síndrome neurocognitivo adquirido, progresivo e irreversible**, caracterizado por un deterioro de las funciones cognitivas (memoria, lenguaje, orientación, juicio, conducta y capacidad funcional), suficiente para interferir con la vida diaria.

Es uno de los **principales problemas de salud pública** en Chile y el mundo, asociado al envejecimiento poblacional.

Epidemiología

- **Prevalencia mundial:** 5–8% en mayores de 65 años.
- **Chile:** estimaciones recientes (MINSAL 2023) indican prevalencia de **7,1% en >60 años**, con **>200.000 personas afectadas**.
- **Causa más frecuente:**
 1. **Enfermedad de Alzheimer (60–70%)**
 2. **Demencia vascular (15–20%)**
 3. **Demencia con cuerpos de Lewy (5–10%)**

Relevancia clínica

- Genera **dependencia funcional progresiva, carga familiar y económica**, y alto riesgo de institucionalización.
- En Chile, se reconoce dentro de las **Condiciones GES** bajo el nombre “**Demencia**” (garantía de diagnóstico, tratamiento y apoyo familiar).
- Su diagnóstico precoz permite **intervención terapéutica y planificación familiar**.

□ En **EUNACOM**, las preguntas suelen plantear un adulto mayor con pérdida de memoria, desorientación o cambios conductuales, donde se debe diferenciar **demencia de delirium y depresión**, y reconocer el tipo específico (Alzheimer, vascular, Lewy).

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Conceptos generales

- **Deterioro cognitivo leve (DCL):** alteración objetiva en memoria u otra función, **sin interferir con la vida diaria.**
- **Demencia:** deterioro de **≥2 dominios cognitivos** con **impacto funcional.**

Los principales dominios son:

1. Memoria
 2. Lenguaje
 3. Función ejecutiva
 4. Atención
 5. Praxia (movimientos)
 6. Gnosia (reconocimiento de objetos)
-

2.2. Enfermedad de Alzheimer (EA)

Fisiopatología:

- **Depósito extracelular de β -amiloide (placas seniles) y enrollamiento intraneuronal de proteína tau (ovillos neurofibrilares)** → disfunción sináptica y muerte neuronal.
- Afecta inicialmente el **hipocampo** y luego se extiende al **córtex temporal y parietal.**
- Disminución de **acetilcolina** cortical → déficit de memoria y cognición.

Factores de riesgo:

- Edad avanzada.
- Antecedente familiar (mutaciones APP, PSEN1/2, APOE ϵ 4).
- Factores cardiovasculares, sedentarismo, depresión previa, bajo nivel educacional.

2.3. Demencia vascular (DV)

Fisiopatología:

- Secundaria a **isquemia o infarto cerebral múltiple**, microangiopatía o lesiones subcorticales.
 - La lesión vascular interrumpe redes neuronales que sostienen funciones cognitivas.
 - Factores de riesgo: **HTA, diabetes, dislipidemia, fibrilación auricular, tabaquismo.**
-

2.4. Demencia con cuerpos de Lewy (DCLewy)

Fisiopatología:

- **Depósitos de α -sinucleína** (cuerpos de Lewy) en neuronas corticales y del tronco encefálico.
 - Compromiso de vías dopaminérgicas y colinérgicas.
 - Genera combinación de **síntomas cognitivos, alucinaciones visuales y parkinsonismo.**
-

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Manifestaciones generales de demencia

- **Pérdida progresiva de memoria reciente.**
- Dificultad para realizar actividades cotidianas.
- Desorientación temporal y espacial.
- Alteraciones del lenguaje (anomia, afasia).
- Cambios conductuales (apatía, irritabilidad, desinhibición).
- Alteraciones del sueño y apetito.

En fases avanzadas: pérdida del reconocimiento familiar, incontinencia, acinesia, dependencia total.

3.2. Características clínicas distintivas

Característica	Alzheimer	Vascular	Cuerpos de Lewy
Inicio	Insidioso, progresivo	Brusco o escalonado	Subagudo, fluctuante
Memoria	Afectación temprana y prominente	Variable, a veces leve	Fluctuante
Función ejecutiva	Comprometida en etapas tardías	Afectada precozmente	Variable
Marcha / focalidad neurológica	Normal hasta fases tardías	Frecuente	Parkinsonismo leve
Alucinaciones visuales	Raras, tardías	No comunes	Frecuentes y tempranas
Fluctuación cognitiva	No	Sí, con variabilidad día a día	Marcada
Respuesta a antipsicóticos	Variable	Variable	Hipersenibilidad grave (rigidez, sedación)

3.3. Diagnóstico diferencial

Entidad	Características distintivas
Delirium	Inicio agudo, fluctuante; conciencia alterada; reversible.
Depresión (“seudodemencia”)	Aparición subaguda, queja subjetiva exagerada; mejora con antidepresivos.
Deterioro cognitivo leve	Afectación mínima, sin impacto funcional.
Trastornos metabólicos o farmacológicos	Hipotiroidismo, déficit B12, intoxicación por benzodiacepinas o alcohol.
☐ En EUNACOM, suelen presentar un caso con “olvido progresivo y pérdida de orientación” para diferenciar Alzheimer (insidioso) de DV (escalonado) y DCLewy (fluctuante + alucinaciones) .	

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Evaluación clínica y funcional

- **Anamnesis detallada:** inicio, evolución y repercusión funcional.
- **Entrevista a familiar/cuidador.**
- **Evaluación funcional:**
 - Actividades básicas (Barthel) y instrumentales (Lawton y Brody).

4.2. Evaluación cognitiva

- **Mini-Mental State Examination (MMSE):** <24 sugiere demencia.
- **Montreal Cognitive Assessment (MoCA):** más sensible a deterioro leve (<26).
- **Test del Reloj:** útil para función ejecutiva.

Según MINSAL, la **pérdida de autonomía funcional + deterioro cognitivo** son criterios diagnósticos esenciales.

4.3. Exámenes de laboratorio

Solicitar para descartar causas reversibles:

- Hemograma, glicemia, función renal, electrolitos.
 - TSH, vitamina B12, ácido fólico.
 - Serología sífilis o VIH (en casos seleccionados).
-

4.4. Neuroimagen

- **TAC cerebral sin contraste:** estudio de primera línea (MINSAL).
 - Descarta lesiones estructurales (tumor, hematoma, hidrocefalia).
 - En Alzheimer: atrofia hipocampal y cortical difusa.
 - En demencia vascular: infartos lacunares, leucoaraiosis.
 - **RM cerebral:** útil en casos atípicos o inicio precoz (<65 años).
 - **SPECT / PET:** opcionales; muestran hipometabolismo temporal-parietal (Alzheimer).
-

4.5. Criterios diagnósticos (DSM-5 / NIA-AA)

Trastorno neurocognitivo mayor (demencia):

1. Evidencia significativa de declinación cognitiva en uno o más dominios.
2. Interferencia con independencia funcional.
3. No explicable por delirium u otro trastorno mental.

Subtipos:

- Alzheimer: progresión insidiosa y gradual sin otra causa.
 - Vascular: relación temporal con evento vascular o lesiones demostradas por imagen.
 - Lewy: fluctuaciones + alucinaciones visuales + parkinsonismo.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El manejo de la demencia es **multidimensional**, orientado a **preservar la función, aliviar síntomas conductuales y apoyar a la familia**.

5.1. Tratamiento farmacológico

a. Enfermedad de Alzheimer

1. **Inhibidores de la acetilcolinesterasa (IACHÉ)** → primera línea.
 - **Donepezilo:** 5–10 mg/día.
 - **Rivastigmina:** 1,5–6 mg c/12h (oral o parche).
 - **Galantamina:** 8–24 mg/día.
 - Mejoran síntomas cognitivos y funcionales, especialmente en fases leve-moderada.
2. **Memantina (antagonista NMDA):** 10–20 mg/día.
 - Indicada en fases moderada a grave o combinada con IACHÉ.

□ Según MINSAL, los IACHÉ son financiados por GES Demencia para Alzheimer leve a moderada.

b. Demencia vascular

- **Control estricto de factores de riesgo cardiovascular:** HTA, diabetes, dislipidemia, tabaquismo.
- **Aspirina o anticoagulación** según etiología (prevención secundaria).

- En algunos casos se usa **donepezilo o memantina**, con evidencia modesta.
-

c. Demencia con cuerpos de Lewy

- **IACHÉ (rivastigmina)** → mejora cognición y alucinaciones.
 - **Evitar antipsicóticos típicos (haloperidol)** → riesgo de reacciones extrapiramidales graves.
 - Si es necesario, usar **quetiapina o clozapina en dosis bajas**.
 - Tratar síntomas parkinsonianos con **levodopa** (efecto limitado).
-

5.2. Intervenciones no farmacológicas

- **Terapia ocupacional y estimulación cognitiva.**
 - **Fisioterapia y ejercicios de equilibrio.**
 - **Rutinas estructuradas y ambiente predecible.**
 - **Apoyo psicoeducativo a cuidadores** (programa nacional MINSAL-CUIDEMOS).
 - **Evitar contención física y fármacos innecesarios.**
-

5.3. Manejo de síntomas conductuales

- Identificar causas reversibles: dolor, infección urinaria, constipación, insomnio.
 - **Medidas ambientales y conductuales** antes de usar fármacos.
 - Si persisten:
 - **Risperidona:** 0,25–1 mg/día (único antipsicótico autorizado en Alzheimer por MINSAL).
 - Vigilar riesgo de caídas, ACV y mortalidad.
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1. Complicaciones

- Caídas y fracturas.
- Desnutrición y úlceras por presión.
- Infecciones respiratorias y urinarias.
- Síndrome confusional agudo (delirium).
- Agitación, depresión y psicosis.
- Sobrecarga del cuidador → depresión del cuidador.

6.2. Pronóstico

- **Alzheimer:** duración media 8–10 años.
- **Vascular:** curso escalonado, peor si hay comorbilidades vasculares.
- **Lewy:** evolución más rápida (5–7 años) con fluctuaciones marcadas.

Factores de peor pronóstico:

- Inicio precoz (<65 años).
- Aislamiento social, comorbilidad médica, institucionalización.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. La **pérdida de memoria reciente** es el síntoma cardinal del Alzheimer.
2. **Demencia vascular** tiene **inicio brusco y curso escalonado**.

3. En **demencia con cuerpos de Lewy**, sospechar si hay **alucinaciones visuales tempranas + parkinsonismo + fluctuaciones**.
 4. Todo paciente con demencia debe tener **TAC o RM** para descartar causas reversibles.
 5. **Risperidona** es el único antipsicótico aprobado por MINSAL para agitación grave en Alzheimer.
 6. **Haloperidol está contraindicado en Lewy** por riesgo de rigidez extrema o muerte.
 7. Siempre evaluar **riesgo de delirium o depresión concomitante**.
-



Errores comunes

- Diagnosticar Alzheimer sin descartar hipotiroidismo o déficit de B12.
 - Usar benzodicepinas o antipsicóticos de forma crónica.
 - No evaluar la funcionalidad (Barthel / Lawton).
 - Ignorar apoyo familiar y educación del cuidador.
 - Suponer que todo anciano con olvido tiene demencia.
 - No diferenciar **demencia** de **delirium** (curso agudo vs. crónico).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **demencia** es un síndrome progresivo que afecta memoria, cognición y funcionalidad, con múltiples causas.
2. **Alzheimer** es la forma más frecuente (60–70%), seguida de **vascular** y **cuerpos de Lewy**.
3. El diagnóstico es **clínico**, apoyado por test cognitivos y neuroimagen estructural.

4. Los **inhibidores de acetilcolinesterasa** y **memantina** son los tratamientos farmacológicos de elección según MINSAL.
5. El **manejo no farmacológico** y **apoyo al cuidador** son esenciales en todos los casos.
6. Evitar **antipsicóticos típicos** en Lewy y **benzodiacepinas** prolongadas.
7. La detección temprana y control de factores vasculares mejoran el pronóstico funcional.